

IMC - 24.13

(H) ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 2223 169 6005 / 071

ELAINE DE FATIMA ARANTES CORREA

IDADE: 69	PESO: 59	ALTURA: 159	PROFISSÃO: Socióloga - Apos.
SINTOMAS: Depressão		tec. enfermagem	
QUEIXAS: memória ruim / Risco			
MEDICAMENTOS: Rivotril (desmamando 10 ^{mg}) / Glifage / Facxina / Desma- pio / Vitaminas / Puran T4 / Plauto progel.			
MÉDICO: Drª Liliame / Drº André			
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N			
EXERCÍCIO FÍSICO: caminhada / fisiot (2x semana)			
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5		ALMOÇO: 5	LANCHES: 5 JANTAR: —
HORA QUE DORME: 23		HORA QUE ACORDA: 7hs (saída cama 9hs)	
COCHILHO () SIM (X) NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 1 a 2x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: Sim	MALLAMPATI:	IAH: 18.	SPO2: 87% Tº Axila 36.1
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Sinusite			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (X) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS dor nos joelhos			
26/04/24 avaliação locação			
03/05 P= 5-8.2 cmH ₂ O			
24	IAH= 3.0	Bem adaptada cl	
m de uso: 10h 20m		quira de boca não	
fluxo: 3 l/min			
Oriento leve de língua			
no cu da boca			
Natacha			
10/05 P= 7 cmH ₂ O			
24	IAH= 2.3 e/h	comprei Aparelho	
m de uso: 10h 11m		Bem adaptada	
Natacha			
24/05/24 P= 7 cmH ₂ O			
IAH= 1.8 e/h			
m de uso: 9h 51		Bem adaptada	
Natacha			
28/06/24 P= 7 cmH ₂ O			
IAH= 1.3 e/h		Desmamando Rivotril	
m de uso: 8h			
Fluxo= 12.1 lpm.		Jua.	

17/09/24 P=7cm H₂O
IAH=4,1 cl/h
m de uso: 5h38'

Agitada, queirando-se de
dous nos feelhos
delata dominencia nos pés
por ino no utiliza

Natacha

10/12/24 P=7cm H₂O
IAH=2,0 cl/h
m de uso: 6h1'
puq: 4,3 l/m

* troco filtro
Mais tranquila e
bem adaptada ao
CPAP

Natacha

28/03/25 P=7cm H₂O
IAH=2,5 cl/h
m de uso: 4h33'
puq: 10,6 l/m

* troco filtro
Viajou por um periodo
e no entezou

Natacha

Nome: ELAINE DE FATIMA ARANTES CORREA

Data de Nascimento: 16-2-1955

IMC: 24,13

Sexo: Feminino

Data do exame: 11-01-2024

Peso: 61 kg

Altura: 1,59 m

Médico: DRA. LIDIANE DA CONSOLAÇÃO

AGAPITO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 11-01-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 544,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 128,5 e 143,0 minutos. O tempo total de sono foi de 388,5 min, eficiência de 71,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,9%; estágio N2: 55,3%; estágio N3: 19,9%; sono REM: 22,8%. O índice de despertares foi de 15,1/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 18,1/hora, sendo 4 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 98 hipopnéias. A SpO2 média foi de 92% e a mínima de 87%, permanecendo 2,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 63 - 85 bpm e NREM de 60 - 89 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (1), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 18,1/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=87%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (11,1/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57